

Leberzirrhose :

Man versteht unter Leberzirrhose das Endstadium vieler chronischer Lebererkrankungen.

Sie zeichnet sich durch den Tod von Leberzellen und deren Ersatz durch Bindegewebe aus, was zum Verlust der Leberfunktion führt.

Epidemiologie:

Die Inzidenz in westlichen Industrieländern (Europa und USA) beträgt etwa 250 Fälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Es erkranken etwa doppelt so viele Männer wie Frauen. Die 10-Jahres-Mortalität der Leberzirrhose liegt ungefähr zwischen 30 und 60 .

Ursachen:

Alkoholische Lebererkrankung: Chronischer Alkoholkonsum ist eine Hauptursache ca. 60% für Zirrhose, insbesondere in westlichen Ländern.

Virale Hepatitis ca. 30% : Hepatitis B, C und D können bei Nichtbehandlung zu Zirrhose führen.

Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD): Diese steht in Zusammenhang mit Fettleibigkeit, Diabetes und Störungen des Lipidstoffwechsels.

Autoimmunerkrankungen: Wie autoimmune Hepatitis oder primäre biliäre Zirrhose.

Stoffwechselerkrankungen: Wie Hämochromatose (Eisenüberladung) oder Morbus Wilson (Kupferstoffwechselstörung).

Medikamente und Toxine: Einige Medikamente und Toxine können Leberschäden verursachen, die zu Zirrhose führen.

Andere: Dazu gehören angeborene Lebererkrankungen, chronische Herzinsuffizienz und parasitäre Infektionen.

Symptome:

Frühstadien der Zirrhose können symptomfrei sein. Mit fortschreitender Erkrankung können Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Gewichtsverlust, Bauchschmerzen, Gefäßspinnen und Gelbfärbung von Haut und Augen (Ikterus) auftreten. In fortgeschrittenen Stadien können Komplikationen wie Aszites (Flüssigkeitsansammlung im Bauch), blutende Varizen (erweiterte Venen in der Speiseröhre oder im Magen, die bluten können), hepatische Enzephalopathie (Verwirrtheit und Schläfrigkeit aufgrund von Leberversagen) und Leberkrebs auftreten.

Diagnose:

Bluttests: Erhöhte Leberenzyme, Bilirubin und andere Marker können auf Leberschäden hinweisen.

Bildgebung: Ultraschall, CT und MRT können Leberschäden

und Tumoren zeigen.

Leberbiopsie: Eine Probe von Lebergewebe wird entnommen, um das Ausmaß der Leberschäden zu untersuchen.

Behandlung:

Lebensstiländerungen: Vermeidung von Alkohol, Erhalt eines gesunden Gewichts und Behandlung zugrunde liegender Zustände können helfen, weitere Leberschäden zu verhindern.

Medikamente: Zur Behandlung der zugrunde liegenden Ursache, Reduzierung von Komplikationen und Symptommanagement.

Lebertransplantation: In schweren Fällen, in denen die Leber stark geschädigt ist, kann eine Lebertransplantation notwendig sein.

Prognose:

Die Prognose hängt von der Ursache und dem Stadium der Zirrhose sowie von der allgemeinen Gesundheit des Patienten ab. Eine frühe Erkennung und Behandlung kann die Prognose verbessern.

Komplikationen wie Leberkrebs, Blutungen und Infektionen können lebensbedrohlich sein.

Prävention:

Impfung: Gegen Hepatitis B und C.

Gesunder Lebensstil: Vermeidung von übermäßigem Alkoholkonsum, Erhalt eines gesunden Gewichts und Behandlung chronischer Zustände.

Regelmäßige Untersuchungen: Insbesondere für Risikopersonen, um Leberschäden frühzeitig zu erkennen.

Quellen :

Sørensen HT, Thulstrup AM, Mellemkjar L, et al. (2003).

Long-term survival and cause-specific mortality in patients with cirrhosis of the liver: a nationwide cohort study in Denmark.

Journal of Clinical Epidemiology 56 : 88–93

PMID: 12589875.

[Universitätsspital Zürich](<https://www.usz.ch> › krankheit ›

[Gesundheit.gv.at](<https://www.gesundheit.gv.at> › leber

[DocCheck Flexikon](<https://flexikon.doccheck.com> › Leberzirrhose